

F	[악화/완화 인자] open question
	[위염/위궤양] 식사하기 전과 후 중에 더 속쓰림이 심해지는 상황이 있나요?
	[젓당불내성] 우유나 기름진 음식을 먹으면 더 속이 쓰린가요?
	[IBS] 대변을 보고 나면 속쓰림이 완화되나요?
	[스트레스] 최근에 스트레스를 받는 일이 있었나요?
	암기법 제우스(우유, 스트레스)는 음식 대기 중
	설명 제우스(우유, 스트레스)는 음식(식사) 대기(대변 본 후, 기름진 음식) 중
E	이전에 건강 검진 받은 적 있으세요?/위내시경, 대장내시경 받으셨나요?/결과는 어땠나요? 간염 예방접종은 다 맞으셨나요? ☞ 위/대장내시경 시행 여부와 결과도 반드시 문도록 합니다.
외	수술을 받으신 적 있나요?/배를 다치신 적 있나요?
과	고혈압/당뇨/고지혈증/간질환 있으신가요? 위염이나 위궤양을 진단 받은 적 있으신가요?
약	복용 중인 약물이 있나요? (아스피린, NSAID, 제산제, 항생제, 스테로이드) ☞ 시간이 없을 경우 진통제(NSAID)와 항생제 복용 여부를 묻습니다.
사	직업이 어떻게 되세요? → 스트레스를 많이 받으시나요? 음주는 하세요?/흡연은 하시나요?/커피는 하루에 몇 잔 정도 드시나요? [식습관] 평소 식사는 규칙적으로 하세요?/맵거나 자극적인 음식을 좋아하시나요? [운동] 운동은 규칙적으로 하시나요?/일주일에 몇 번 정도 하세요?
가	가족 중에 위암이나 위궤양 등을 진단받은 분이 있으신가요?
여	실례지만 마지막 월경 시작일이 언제인가요?/월경 주기?/월경통/월경량 심한 편? 임신 가능성이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 혈력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기!). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입인두 : 위산 역류 3. 목★ : 림프절 촉진(supraclavicular lymph node까지 촉진) 4. CVAT : (복통 호소 시 시행을 고려합니다.) 뒤로 돌아주세요. 반드시 양쪽 다 확인, 양쪽을 한번씩만 치는 것이 아니라 연속적으로 위에서 내려가며 여러 번 쳐준다.

[누워서] 5. 복부★

신진 수술 흔적, 팽만/청진 5구역, 3초간/타진 4군데 이상/촉진 알, 깊 촉진

⊕ 황달 있거나 간질환 의심 시 : 간, 비장 타진 및 촉진

[특이검사★] Murphy's sign

6. DRE : 직장수지검사

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	소화불량 or 속쓰림 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 위궤양이 가장 의심됩니다. [병력 상 당뇨가 오래 조절되지 않은 경우] 당뇨병 위마비 등으로 당뇨가 소화불량 원인일 수 있습니다. 이 경우 혈당을 엄격하게 조절하는 것이 중요합니다.
감별 진단	그러나 최근 체중이 감소하고 식욕 변화도 있으면서 평소 음주와 흡연력도 있으셔서 위암의 가능성을 배제할 수는 없습니다.
검사	이런 경우 위내시경검사로 위에 어떤 기질적 문제가 있는지 확인하는 것이 필요합니다. 검사를 진행해도 괜찮을까요? 검사를 위해 지금부터 금식을 하셔야 합니다.
치료	만약 위궤양으로 진단되면 위산 분비를 억제하는 약을 드리고 제균 치료를 시행해 볼 수 있습니다. 만일 위암으로 진단되면 수술이나 항암 치료 등이 필요할 수 있습니다. 가능성 소화불량으로 진단 시 생활 습관을 개선하고 소화불량을 일으키는 약물을 중단하고, 추가로 위산억제제나 위장운동촉진제 약물 치료를 병행할 수 있습니다.
예후	하지만 아직 검사를 진행한 것이 아니기 때문에 너무 걱정하지는 마세요. 이렇게 증상이 빨리 나타났을 때 병원에 오신 것은 정말 잘하신 것입니다.
교육	[응급] 지금은 증상이 심하지 않지만 집에 가서서 음식을 삼키기 힘들거나, 어지럽고, 피를 토하거나 변에 피가 묻어나오거나 검은 변을 보면 즉시 병원을 방문해 주세요. [식습관] 생활 속에서 맵거나 자극적인 음식을 피해주시고, [생활 습관] 적절히 운동을 해주면서 스트레스를 덜 받게 하는 것 또한 중요합니다. 금연과 금주가 중요하며, 카페인의 경우 위산 분비를 촉진시키니 섭취를 줄여준다면 증상 완화에 더 도움이 됩니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획★

- ① 복부 X-ray, 복부 CT
- ② 위식도내시경
 - 45세 이상
 - 악성 경고 증상 +
 - 만성 증상에 변화 +
 - 환자가 악성 종양에 대해 걱정할 때
- ③ 궤양 : 요소나소검사, 신속요소분해효소검사(위내시경 시 같이 시행)
- ④ GERD : 24시간 식도 pH검사

❖ 치료 계획

위장관	위식도역류	양성자펌프억제제, 제산제, 생활 습관 교정
	위궤양	양성자펌프억제제, <i>H. pylori</i> 제균 치료, 제산제
	십이지장궤양	양성자펌프억제제, <i>H. pylori</i> 제균 치료, 제산제
	위암	위절제술, 내시경적 점막하절제술, 항암 치료
간담체	담석증/만성 담낭염	금식 유지, 항생제, 수액
	만성 췌장염	금식 유지, 췌장효소 보충, 혈당 조절
	간염	항바이러스제, 보존적 치료
기타	기능성 소화불량	심리적 안정, 적절한 운동과 휴식
	과민대장증후군	심리적 안정
	당뇨성 마비	당뇨 조절
	젖당불내성	유당 회피

❖ 환자 안내 / 생활 습관 교육

- ① 생활 습관 개선의 중요성 : 술/담배 제한, 적절한 유산소 운동, 체중 조절, 식습관 개선(규칙적 식습관, 지방이 적고 섬유소가 많은 음식), 스트레스 관리, 카페인 제한

- ② 당뇨병이 조절되지 않고 있는 경우 당뇨가 소화불량의 원인일 수 있음을 설명하고 엄격한 조절 강조
- ③ 기질적 문제가 의심되는 경우 복부 CT 등 추가적인 검사가 필요할 수 있음을 강조



keyword

소화불량/만성 복통의 경우 기능성/기질적/그 외(약물 복용 등) 원인으로 나누어
감별하기

소화불량의 위치를 확인해 기질적 원인인 경우 감별하기

기질적 원인의 위험 요인 파악 : 커피, NSAIDs, 항생제 복용 과거력, 스트레스, 음주/흡연

교육 : 생활 습관 개선(식습관+운동), 스트레스 조절, 금주/금연/카페인 섭취도 줄일 것을 교육하기

응급 상황 교육 : 연하곤란, 어지럼, 토혈, 혈변/흑색변 시 내원 교육



Memo



시청 환경 코멘트



토혈로 내원 시 가장 먼저 기침 유발인지 확인 후 **객혈과 감별**합니다.

이후에 색깔, 거품 여부, 음식 여부, 기침 유발 여부 등을 바탕으로 문진이 필요합니다. 또한 토혈의 경우 응급 상황일 수도 있으므로 **토혈의 양과 응급 증상에** 해

당하는 **어지럼증, 호흡곤란, 소변량 감소** 등을 물어보고 해당 증상을 호소하는 경우 수액을 달아 준다는 언급을 한다면 의사-환자 관계에서 좋은 점수를 얻을 수 있을 것입니다.

토혈 증례에서는 **말로리-바이스 증후군과 감별하는 것이 중요하므로 음주력을 물어보는 것**을 잊지 마세요. 상하부 위장관 출혈에서는 **변 색깔**이 중요한 감별점이 됩니다. 또한 출혈과 관련된 경우 출혈 경향성과 **관련 약물(NSAIDs, 항응고제)**도 잊지 말고 물어보세요.

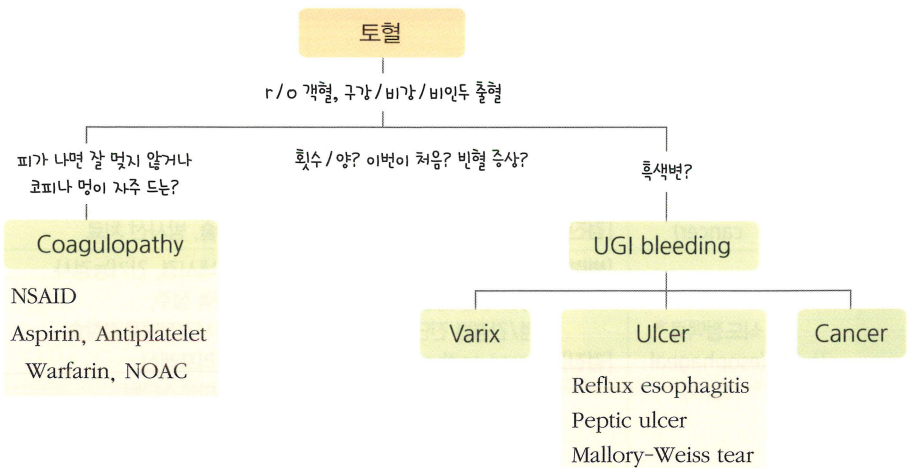
토혈이나 객혈, 혈소 등 피가 나올 수 있는 상황들에 대해서는 환자들이 많이 놀라고 당황하는 기색을 보이는데, 이를 잘 이해하고 진정시켜 주는 태도 또한 의사-환자 관계에 중요합니다. 신체 진찰에선 우선 혈압, 맥박을 확인하여 응급 상황인지 판단하여야 합니다. 또한 식도정맥류 출혈 감별을 위해 피부의 Flapping tremor, 흉부 진찰 시 가슴까지 옷을 올려 거미혈관종을 확인하는 등 **간질환 관련 신체 검진을 빼먹지 않는 것이 중요합니다**. Flapping tremor나 Shifting dullness처럼 특징적인 신체 검진을 충분히 연습해 두면 도움이 될 것입니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
식 도	-	역류 식도염 (reflux esophagitis)	[병력] 소량의 피, 신물이 올라옴, 속쓰림 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경, 24시간 식도 pH검사 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제, 생활 습관 교정
	-	식도암★ (esophageal cancer)	[병력] 담배를 많이 피, 나이 많음, 연하곤란, 체중 감소 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경, 흉부 CT [치료] 수술, 방사선 치료
	간	식도정맥류★ (esophageal varix)	[병력] 많은 양의 토혈, 간경변 증상(황달, 복부 팽만), 간염/간경변 진단 [검진] Palmar erythema, 복수, Flapping tremor, Spider angioma, Caput medusae	[검사] 위내시경, 간기능검사 [치료] 수액 정주, 내시경정맥류결찰술, 텔리프레신, 소마토스타틴, 베타 차단제(예방 목적)

위	음주	말로리-바이스 증후군★ (mallory-weiss syndrome)	[병력] 음주 후 구토하던 중 토혈 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경 [치료] 수액 정주 및 안정
	-	위궤양★ / 십이지장궤양★	[병력] 식전/후 속쓰림, 많은 양의 토혈, 소화불량 [검진] 상복부 압통	[검사] 위내시경, 신속요소분해효소검사 [치료] (대량 토혈) 내시경지혈술, 양성자펌프억제제, <i>H. pylori</i> 제균 치료, 제산제, 교육
	-	소화성 궤양 천공	[병력] 식전/후 속쓰림, 다량 토혈, 소화불량+발열, 오한, 심한 복통 [검진] 복부 전체 압통/반발 압통	[검사] 흉부 X-ray, 복부 CT [치료] 응급 개복 수술
	-	위암★	[병력] 체중 감소, 소화불량, 속쓰림(증상 없을 수도) [검진] 특이 소견 없을 수 있음	[검사] 위내시경, 복부 CT [치료] 위절제술, 내시경점막절제술, 항암 치료
혈액	-	응고장애	[병력] 출혈 경향, 아스피린 등 약제 복용력	-

증례별 알고리즘



STEP 1 병력 취취

O	언제 피를 토하셨나요?/갑자기 발생했나요?/어떤 상황에서 피를 토했나요?
L	-
D	몇 번이나 피를 토하셨나요?
Co	피의 양이 점점 늘어나나요? → 심해지고 있나요?
Ex	이전에도 이런 증상이 있으셨나요? 그때는 치료를 받으셨나요?
C	[객혈과 감별] 거품이 있었나요?/기침하다가 토해진 않았나요? 코나 입에서 피가 나오진 않았나요?/음식물이 섞여 있었나요? 가래가 섞여 있었나요? 암기법 거기 코와 입에 응가 설명 코나 입에서 나는 피는 출혈 경향 associated symptoms에 포함됨 출혈량이 얼마나 되나요? (소주잔 또는 종이컵 기준) 색깔은 어떤가요? (선홍색/검붉은색)/피떡이 있었나요?
A	[전신] 발열/오한/피로/체중 감소(식도암, 위암 감별) [과다 출혈, 탈수] 목마름/호흡곤란/두근거림/어지럼증/소변량 감소가 있나요? 암기법 마른 호두를 어지럽힌 소감 설명 마른(목마름) 호두(호흡곤란, 두근거림)를 어지럽힌(어지럼) 소감(소변량 감소) [출혈 경향] 멍이 잘 들/코피, 출혈 후 잘 안 멎음/생리량이 많아졌나요? 암기법 멍 때리니까 코피가 안 멎지 설명 멍(멍이 잘 들) 때리니까 코피(코나 입에서 피)가 안 멎지(출혈 후 안 멎음) [소화기] 식욕 저하/구역감/설사/변비/흑색변/혈변/명치 통증/소화불량이 있나요? [역류 식도염/식도암] 신물 올라옴/속쓰림/연하곤란이 있나요? [식도정맥류 파열] 황달/복부 팽만/소변색이 진해졌나요?/대변색 변화가 있나요? [말로리-바이스] 토하기 전에 과음하셨나요?
F	[악화] 통증이 있다면 식사와 관련 있나요?

E	이전에 건강 검진 해 보셨나요?/위내시경도 하셨나요?/간염 예방접종은 다 맞으셨나요?
외	복부 수술 받으신 적 있나요?/복부를 다친 적이 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (소화기 질환)
약	복용 중인 약물이 있나요?/피를 묽게 하는 약(아스피린 등) 먹고 있나요?
사	술, 담배, 커피는 하시나요?/직업이 어떻게 되시나요? [식습관] 평소 식사는 규칙적으로 하세요?/맵거나 자극적인 음식을 좋아하시나요? [운동] 운동은 규칙적으로 하시나요?/일주일에 몇 번 정도 하세요?
가	가족 중 간질환이 있는 분 있나요? 가족 중 소화기계 관련 질환 있으신 분 있었나요?
여	[월경력] LMP/규칙적/주기/생리량/생리통/임신 가능성
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [출혈★] 혈압, 맥박 보고 응급인지 확인하는게 먼저 [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 코★ : 비경 이용하여 비강 내 출혈 확인 3. 입★ : 혀 탈수 소견, 구강 내 출혈, 인두에 피떡 확인 ☞ 설상자조 구강의 출혈을 확인합니다. 4. 목 : 경부 림프절 촉진 + 가슴 시진(spider angioma) 5. 손(피부)★ : 피부 긴장도, Palmar erythema, Flapping tremor [누워서] 6. 복부(간)★ [시진] 수술 흔적/복부 팽만/Spider angioma/Caput medusae [청진] 차가우실 수 있어요./5구역, 3초씩 [타진] 타진 4군데/간, 비장 타진/복수(shifting dullness) [촉진] Superficial 4군데, Deep 4군데, 통증 있으면 반동 압통도/간, 비장 촉진 7. DRE : 직장수지검사
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 혈압 측정 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?